



Afecções Anorretais Fundamentos, Diagnóstico e Principais Doenças

Apostila 1 — Especialização em Coloproctologia | Módulo Introdutório

PARTE 1 DE 2

PÁGINAS 1-20

Visão Geral das Afecções Anorretais

As doenças anorretais figuram entre as afecções mais prevalentes tanto no atendimento ambulatorial quanto nos serviços de urgência e emergência. Compreender sua fisiopatologia, apresentação clínica e abordagem diagnóstica é condição indispensável para qualquer especialista em formação.

Pontos-chave do cenário clínico

- A **grande maioria** das afecções anorretais é de natureza benigna
- **Sangramento anal** é o sintoma mais frequente, porém inespecífico — exige investigação
- **Hemorroidas** representam a principal etiologia do sangramento
- Outros sintomas prevalentes: dor anal, prurido e sensação de massa perianal

Pilar do diagnóstico

O raciocínio diagnóstico nas afecções anorretais é fundamentalmente clínico. A **história detalhada** aliada ao **exame físico minucioso** — inspeção e toque retal — orienta a conduta na maioria dos casos, com exames complementares reservados para situações específicas.



Nunca subestime o exame físico: ele é insubstituível na coloproctologia.

Anatomia Anorretal: Estruturas Musculares

O conhecimento aprofundado da anatomia anorretal é o alicerce sobre o qual se constroem o diagnóstico e o tratamento de todas as afecções dessa região. A musculatura do assoalho pélvico e os esfínteres anais desempenham papéis funcionais distintos e complementares.



Músculo Levantador do Ânus

Principal componente do diafragma pélvico. Responsável pelo suporte das vísceras pélvicas e pelo alçamento do canal anal durante a defecação. Sua integridade é fundamental para a continência fecal.



Músculo Puborretal

Porção especializada do levantador do ânus que forma uma alça posterior ao reto. Cria o **ângulo anorretal** de aproximadamente 90°, essencial para o mecanismo de continência em repouso e em esforço.



Esfíncter Anal Interno (EAI)

Musculatura lisa de contração **involuntária**, continuação da camada muscular circular do reto. Responsável por cerca de 70–85% do tônus de repouso do canal anal. Controlado pelo sistema nervoso autônomo.



Esfíncter Anal Externo (EAE)

Musculatura estriada de contração **voluntária**, sob controle somático. Permite ao indivíduo adiar a defecação em situações socialmente inadequadas. Pode ser treinado e reabilitado através de biofeedback.

Continência Fecal

Resultado da ação coordenada entre esfínteres, puborretal e sensibilidade retal

Suporte Visceral

O diafragma pélvico sustenta bexiga, útero/próstata e reto contra a pressão intra-abdominal

Separação Anatômica

Barreira entre cavidade pélvica e espaço perineal, com implicações cirúrgicas fundamentais

Estrutura do Reto e Relações Anatômicas

Características do Reto

O reto está situado na cavidade pélvica, entre o sacro posteriormente e a bexiga/próstata ou útero anteriormente. Mede aproximadamente **12 a 15 cm** de comprimento, desde a junção retossigmoidiana até a linha anorretal.

Sua principal função é o **armazenamento temporário das fezes** antes da defecação. Ao se distender, desencadeia o reflexo de defecação e relaxamento do esfíncter anal interno (RAIR — Reflexo Anocutâneo Inibitório Retal).

- Reto superior: peritônio revestindo anterior e laterais
- Reto médio: apenas face anterior coberta
- Reto inferior: totalmente extraperitoneal

Relações Anatômicas Críticas

Anterior — Homem

Próstata, vesículas seminais, ductos deferentes e bexiga. Espaço de Denonvilliers separa reto da próstata.

Anterior — Mulher

Vagina, colo uterino e corpo do útero. Fundo de saco de Douglas: ponto mais declive da cavidade peritoneal.

Posterior

Sacro e cóccix, fáscia pré-sacral, plexo hipogástrico — estruturas a preservar na dissecação cirúrgica.

Laterais

Fossas isquiorretais, ureter, vasos ilíacos. Ligamentos laterais do reto contêm ramos do plexo pélvico.

Canal Anal: Estrutura e Importância Funcional

O canal anal é a porção terminal do tubo digestivo, medindo **3 a 4 cm** de comprimento no adulto. Estende-se desde a linha pectínea (ou denteada) superiormente até a borda anal (linha anocutânea) inferiormente. É a região onde ocorre a maior parte das afecções abordadas nesta apostila.

Estruturas do Canal Anal

- **Colunas anais de Morgagni:** 8 a 14 pregas longitudinais da mucosa, mais proeminentes no polo superior
- **Criptas anais:** recessos formados na base das colunas, na linha pectínea — local de abertura das glândulas anais
- **Glândulas anais:** estruturas microscópicas que se estendem para a submucosa e musculatura — **origem da maioria das infecções anorretais**
- **Linha pectínea (denteada):** marco anatômico fundamental que separa epitélio colunar (acima) de epitélio escamoso (abaixo)

O Ângulo Anorretal

Formado pelo músculo puborretal, o ângulo anorretal de **$\sim 90^\circ$ em repouso** e **$\sim 110-130^\circ$ na defecação** é um dos mecanismos mais importantes da continência fecal. Sua alteração — por trauma obstétrico, cirurgia pélvica ou lesão neurológica — pode resultar em incontinência grave.

📌 A linha pectínea divide zonas de drenagem linfática, venosa e inervação sensitiva distintas — com implicações clínicas e cirúrgicas diretas.

Vascularização Anorretal e Implicações Clínicas

O entendimento da vascularização da região anorretal é indispensável tanto para compreender a fisiopatologia das doenças (como as hemorroidas) quanto para orientar procedimentos cirúrgicos com segurança.

Sistema Arterial

1 Artéria Retal Superior

Ramo terminal da artéria mesentérica inferior. Irriga o reto superior e médio, além das colunas hemorroidárias internas. Ligada no tempo vascular das ressecções retais.

2 Artéria Retal Média

Originária da artéria ilíaca interna (hipogástrica). Irriga o reto médio e inferior. Variável em calibre e presença bilateral.

3 Artéria Retal Inferior

Ramo da artéria pudenda interna. Irriga o canal anal e o esfíncter externo. Essencial na perfusão da anastomose coloanal.

Sistema Venoso e Implicações

O retorno venoso da região anorretal drena para **dois sistemas distintos**, o que tem grande relevância clínica:

▲ Porção Superior

Acima da linha pectínea → drena para o **sistema porta** via veias retais superiores e mesentérica inferior. Plexo hemorroidário interno. Hemorroidas internas ocorrem nessa região.

▼ Porção Inferior

Abaixo da linha pectínea → drena para o **sistema sistêmico** via veias pudendas e ilíacas internas. Plexo hemorroidário externo. Hemorroidas externas se formam aqui.

📌 Essa dualidade explica por que metástases retais baixas podem escapar do fígado e ir diretamente ao pulmão — com impacto no estadiamento e tratamento oncológico.

Avaliação Clínica: Anamnese e Exame Físico

Uma avaliação clínica estruturada e metódica é o primeiro e mais importante passo na abordagem das afecções anorretais. A maioria dos diagnósticos pode ser estabelecida com base exclusivamente na história e no exame físico.

Anamnese Direcionada

- **Tipo e característica do sintoma:** dor, sangramento, prurido, massa, corrimento, incontinência ou constipação
- **Tempo de evolução:** sintoma agudo (dias) versus crônico (semanas a meses)
- **Relação com hábito intestinal:** constipação, diarreia, urgência defecatória
- **Histórico familiar:** câncer colorretal, doença inflamatória intestinal, polipose
- **Tratamentos prévios:** uso de supositórios, pomadas, cirurgias anteriores
- **Comorbidades:** doença de Crohn, imunossupressão, HIV, diabetes

Exame Físico Sistemático

Posicionamento

Posição de Sims (decúbito lateral esquerdo) ou genupeitoral. A posição de litotomia é reservada para procedimentos.

Inspeção

Afasta as nádegas e inspeciona a região perianal quanto a fissuras, fístulas, hemorroidas externas, lesões cutâneas e secreção.

Toque Retal

Avalia tônus esfinteriano, presença de massas, dor localizada, sangue no dedo e próstata no homem.

Anuscopia: Exame Fundamental do Canal Anal

O que é e por que fazer?

A anuscopia é o exame endoscópico de menor complexidade e maior rendimento diagnóstico na propedêutica anorretal. Realizada com o anuscópio — instrumento tubular rígido de 7 a 10 cm — permite visualização direta do canal anal e do reto distal em consultório, sem necessidade de sedação.

Indicações Principais

- Sangramento anal de origem indeterminada
- Investigação de hemorroidas internas e graduação
- Identificação de fissuras no canal proximal
- Visualização de criptas e glândulas anais inflamadas
- Diagnóstico de proctite, tumores e pólipos do reto distal
- Biópsia de lesões suspeitas
- Procedimentos terapêuticos: ligadura elástica, escleroterapia

📌 A anuscopia complementa o toque retal e deve ser realizada de rotina na consulta coloproctológica — é rápida, segura e de baixo custo.

Contraindicações Relativas

- Fissura anal aguda com dor intensa (considerar anestesia local)
- Estenose anal severa
- Cooperação impossível do paciente

O que a anuscopia permite identificar

Hemorroidas

Visualização direta dos mamilos hemorroidários internos nas posições 3h, 7h e 11h

Fissuras e Inflamações

Lesões lineares, criptas inflamadas, secreção purulenta

Tumores

Lesões polipoides, ulceradas ou vegetantes do canal anal e reto distal

Fissura Anal: Definição e Fisiopatologia

A fissura anal é uma **lesão linear ulcerada** localizada na pele e mucosa do canal anal distal, geralmente na linha média posterior (90% dos casos) ou, menos frequentemente, na linha média anterior. É a **principal causa de dor anal**, superando mesmo o abscesso anorretal em frequência de queixa ambulatorial.

Classificação: Aguda vs. Crônica

Fissura Aguda

Lesão superficial com menos de 6 semanas de evolução.
Bordas regulares, sem fibrose.
Responde bem ao tratamento clínico conservador. Alta taxa de cicatrização espontânea.

Fissura Crônica

Mais de 6 semanas. Apresenta tríade clássica: **úlcera com fibrose + papila anal hipertrófica + plicoma sentinela**. Menor taxa de resposta ao tratamento clínico isolado.

Causas e Fatores Predisponentes

- **Trauma local:** fezes volumosas e endurecidas, constipação crônica
- **Diarreia crônica:** por lesão repetida da mucosa
- **Doença inflamatória intestinal:** especialmente Doença de Crohn — fissuras atípicas, laterais ou múltiplas
- **Hipertonia do esfíncter interno:** perpetua a lesão por isquemia local
- **Pós-parto:** trauma do assoalho pélvico
- **DSTs:** sífilis, herpes — considerar em fissuras atípicas

Fissura Anal: Sintomas, Diagnóstico e Tratamento

Apresentação Clínica

A tríade sintomática da fissura anal é característica e, na maioria das vezes, suficiente para o diagnóstico clínico:

- **Dor anal intensa durante e após a evacuação** — descrita como "faca" ou "vidro cortando", podendo durar horas
- **Sangramento de pequena monta** — sangue vivo no papel, raramente no vaso
- **Espasmo do esfíncter anal interno** — agrava a isquemia local e perpetua o ciclo de dor → espasmo → isquemia → não cicatrização
- Irritação e prurido local podem estar presentes

📌 📌 O ciclo vicioso dor-espasmo-isquemia é o principal mecanismo que impede a cicatrização da fissura crônica.

Tratamento Conservador (~90% de sucesso)

01

Higiene e Hidratação

Banhos de assento 2–3x/dia com água morna por 10–15 min. Aumentam o fluxo sanguíneo local e reduzem o espasmo.

02

Regularização do Hábito Intestinal

Laxantes osmóticos (lactulose, polietilenoglicol), aumento de fibras e hidratação. Elimina o fator causal.

03

Anestésicos e Emolientes Tópicos

Lidocaína gel ou pomadas com corticoide para alívio sintomático da dor durante evacuações.

04

Vasodilatadores Tópicos

Nitratos (trinitroglicerina 0,2%) ou bloqueadores do canal de cálcio (diltiazem 2%) — relaxam o EAI e melhoram a perfusão. Efeito colateral: cefaleia.

Fissura Anal: Tratamento Avançado

Quando o tratamento conservador falha após 6–8 semanas, ou na presença de fissura crônica com fibrose estabelecida, está indicado escalonamento terapêutico. O objetivo de todas as modalidades avançadas é o mesmo: **reduzir o hipertono do esfíncter anal interno** para quebrar o ciclo isquêmico e permitir a cicatrização.



Toxina Botulínica

Injeção de **20–50 unidades** de toxina botulínica A diretamente no esfíncter anal interno, sob visão direta ou guiada. Provoca paralisia química temporária do músculo, reduzindo o tônus por 3–6 meses. Taxa de cura de 60–80%. Permite cicatrização sem cirurgia. Principal vantagem: ausência de risco de incontinência permanente.



Esfínterectomia Lateral Interna (ELI)

Procedimento cirúrgico de escolha para fissura crônica refratária. Consiste na secção parcial controlada do esfíncter anal interno na posição lateral (3h ou 9h), evitando a linha média. Taxa de cura superior a **95%**. Principal risco: incontinência a gases ou fezes (1–5% dos casos). Deve ser realizada com critério, especialmente em mulheres com parto vaginal prévio.

📌 A escolha entre toxina botulínica e cirurgia deve considerar: idade do paciente, sexo, paridade (mulheres), função esfíncteriana basal e disponibilidade de seguimento. Em pacientes de alto risco para incontinência, a toxina é preferida.

Abscesso Anorretal: Definição, Origem e Bacteriologia

O abscesso anorretal é definido como uma **coleção purulenta decorrente da infecção de uma ou mais glândulas anais**. É a segunda causa mais comum de dor anal na prática clínica coloproctológica, superado apenas pela fissura. Sua relevância vai além do episódio agudo: em até **50% dos casos**, evolui para fistula anorretal cronicamente.

Teoria Criptoglandular

A hipótese mais aceita é a **teoria criptoglandular de Parks**: bactérias intestinais colonizam as glândulas anais (localizadas nas criptas da linha pectínea), causando obstrução ductal e infecção. O processo inflamatório diseca os planos musculares e tecidos perianais, formando coleções em espaços anatômicos específicos.

- Flora mista aeróbia-anaeróbia predomina
- *Escherichia coli*, *Bacteroides* spp., *Streptococcus* spp.
- Em imunossuprimidos: *Staphylococcus aureus*, fungos

Fatores Predisponentes

- **Diabetes mellitus** — imunomodulação e isquemia tecidual
- **Doença de Crohn** — inflamação transmural facilita formação de abscessos atípicos
- **Imunossupressão** — HIV, corticoterapia, quimioterapia
- **Trauma e corpo estranho retal**
- **Neoplasia** — rara, mas deve ser excluída



📌 Todo abscesso anorretal sem fator etiológico aparente em paciente jovem deve levantar suspeita de Doença de Crohn ou HIV.

Tipos de Abscesso Anorretal e Quadro Clínico

Classificação por Localização



Quadro Clínico por Profundidade

Abscessos Superficiais (Perianal / Isquiorretal)

Sintomas locais evidentes:

dor pulsátil e progressiva na região perianal, eritema e hiperemia cutânea, edema e flutuação à palpação, calor local. O diagnóstico é essencialmente clínico — a inspeção e o toque retal são suficientes na maioria dos casos.

Abscessos Profundos (Interesfínctérico / Suprilevantador)

Sintomas sistêmicos

predominam: febre alta ($>38,5^{\circ}\text{C}$), calafrios, toxemia, dor pélvica difusa ou dificuldade para urinar. A ausência de sinais externos não exclui coleção profunda. Tomografia computadorizada é essencial nesses casos.

📌 O abscesso isquiorretal pode atravessar a linha média posteriormente (abscesso em ferradura — horseshoe abscess) e exige drenagem bilateral.

Abscesso Anorretal: Diagnóstico e Tratamento

Propedêutica Diagnóstica

O diagnóstico é **predominantemente clínico** nos abscessos superficiais. A complementação por imagem é reservada para situações específicas:

01

Exame Físico

Inspeção da região perianal: eritema, edema, flutuação. Suficiente para abscessos perianais.

02

Toque Retal

Identifica abaulamento, flutuação intraluminal e dor exacerbada. Avalia espaço interesfínctérico.

03

Tomografia Computadorizada

Indicada em abscessos profundos, febre sem foco aparente, suspeita de supralevantador ou recidiva.

04

Ultrassom Endoanal

Delineia a relação do abscesso com os esfíncteres — útil no planejamento cirúrgico.

Tratamento: Drenagem é a Regra

O tratamento do abscesso anorretal é **cirúrgico e urgente**. Não há espaço para conduta conservadora exclusiva — o antibiótico isolado não substitui a drenagem.

Drenagem Cirúrgica

Incisão ampla o mais próximo possível do ânus (evitar trajeto longo de fístula futura), com desbridamento da cavidade e irrigação. Não suturar — deixar aberto para cicatrização por segunda intenção.

Antibioticoterapia: Quando Indicar?

Reservada para: diabetes, imunossupressão, valvopatia, celulite extensa, sepse ou infecção por MRSA. **Não substitui a drenagem** em nenhuma circunstância.

Complicação Temida

Até **50% dos abscessos** evoluem para fístula anorretal — complicação crônica que exigirá cirurgia específica.

Fístula Anorretal: Definição e Fisiopatologia

A fístula anorretal é definida como uma **comunicação anômala e epitelizada entre o canal anal (orifício interno) e a pele perianal (orifício externo)**, revestida por tecido de granulação ou epitélio. Em mais de **90% dos casos**, resulta de um abscesso anorretal prévio não completamente tratado, com persistência da glândula infectada como foco crônico.

Classificação de Parks (pela relação com os esfíncteres)

→ Interesfincteriana (~45%)

Trajetos passam entre os esfíncteres interno e externo. Mais comum. Abordagem cirúrgica mais simples com menor risco de incontinência.

→ Transesfincteriana (~30%)

Atravessa ambos os esfíncteres. Requer avaliação cuidadosa da quantidade de músculo comprometida antes da cirurgia.

→ Supraesfincteriana (~20%)

Passa acima do esfíncter externo e pelo levantador. Complexa — técnicas preservadoras obrigatórias.

→ Extraesfincteriana (~5%)

Sem relação com o complexo esfíncteriano. Geralmente associada a Crohn, trauma ou corpo estranho.

Regra de Goodsall

Diretriz clínica clássica para prever o trajeto da fístula com base na localização do orifício externo:

- **Orifício externo anterior à linha transanal:** trajeto direto (radial) ao canal anal
- **Orifício externo posterior à linha transanal:** trajeto curvo abrindo na cripta posterior da linha média
- **Exceção:** orifícios anteriores a mais de 3 cm do ânus seguem a regra posterior

📌 A Regra de Goodsall é um guia clínico — o planejamento cirúrgico definitivo requer exame sob anestesia e, em fístulas complexas, ressonância magnética pélvica.

Fístula Anorretal: Diagnóstico

O diagnóstico da fístula anorretal baseia-se na integração de achados clínicos, exame físico e, nos casos complexos, métodos de imagem de alta resolução. A identificação precisa do trajeto fistuloso e sua relação com os esfíncteres é determinante para o planejamento cirúrgico seguro.



Exame Físico

Inspeção identifica o(s) orifício(s) externo(s) — pontos elevados, eritematosos, com secreção purulenta ou serossanguinolenta. A palpação do trajeto fistuloso sob a pele (cord sign) pode ser perceptível. Importante documentar número de orifícios externos e localização.



Anuscopia

Permite identificar o **orifício interno** na linha pectínea, geralmente na cripta correspondente. Pode-se injetar soro com azul de metileno pelo orifício externo para confirmar comunicação. Indispensável antes de qualquer cirurgia.



Ressonância Magnética Pélvica

Padrão-ouro para fístulas complexas. Determina com precisão o trajeto, extensão, extensões secundárias (horseshoe), relação com esfíncteres e presença de coleções residuais. Fundamental para fístulas recidivadas ou associadas a Crohn.



Colonoscopia

Indicada quando há suspeita de doença inflamatória intestinal (Crohn), neoplasia, ou fístula com orifício interno alto. Permite biópsia de lesões suspeitas. Não é exame de rotina para fístulas simples.

Fístula Anorretal: Tratamento Cirúrgico

O tratamento da fístula anorretal é **essencialmente cirúrgico**. O princípio fundamental é extirpar o trajeto fistuloso sem comprometer a função esfincteriana — equilíbrio delicado entre cura da fístula e preservação da continência. A escolha da técnica depende fundamentalmente da **classificação da fístula** e da quantidade de músculo esfincteriano envolvida.

Fístulas Simples (Baixas)

01

Fistulotomia

Abertura completa do trajeto fistuloso (marsupialização). Gold standard para fístulas interesfincterianas e transesfincterinas baixas. Taxa de cura >95%. Risco de incontinência mínimo se <30% do EAE comprometido.

02

Setonagem

Passagem de fio (seton) pelo trajeto. Pode ser usada como medida temporária (seton de drenagem) ou como técnica de corte lento (cutting seton) em fístulas com maior envolvimento esfincteriano.

Fístulas Complexas (Altas) — Técnicas Preservadoras

Técnica LIFT (Ligation of Intersphincteric Fistula Tract)

Ligadura e divisão do trajeto no espaço interesfinctérico, sem secção do esfíncter. Taxa de cura 60–80%. Baixo risco de incontinência. Técnica de eleição para fístulas transesfincterinas com seton preparatório.

Retalho de Avanço (Flap)

Cobertura do orifício interno com retalho mucoso ou musculomucoso. Taxa de cura 50–75% na primeira tentativa. Boa opção em fístulas supraesfincterinas.

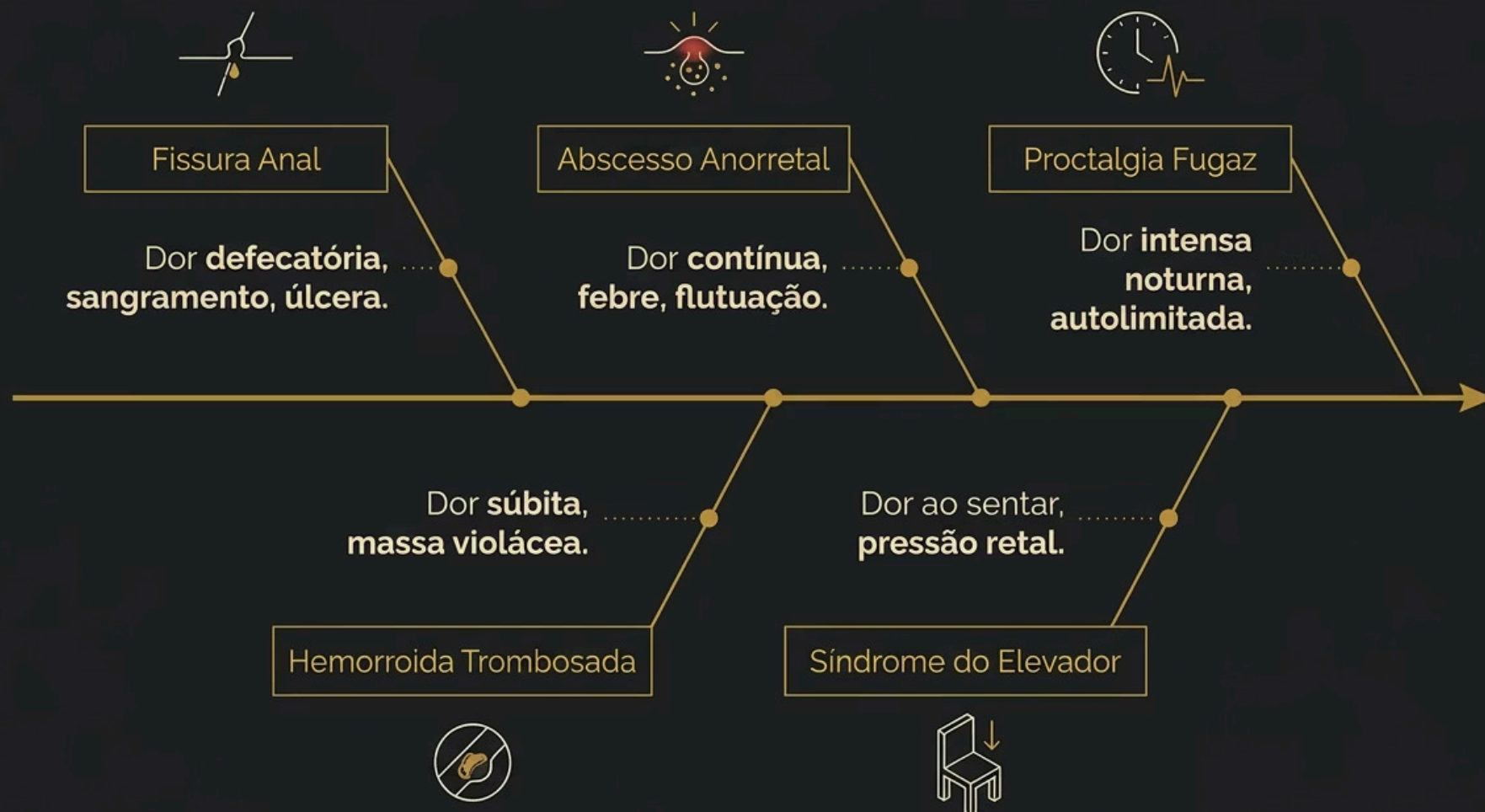
Plug de Colágeno / Colas Biológicas

Obliteração do trajeto com material bioabsorvível. Menor taxa de cura (~50%), mas sem risco de incontinência — útil em pacientes com função esfincteriana comprometida.

📌 Em pacientes com Doença de Crohn, o controle da atividade inflamatória sistêmica (biólogicos, imunossupressores) é condição obrigatória antes de qualquer cirurgia definitiva da fístula.

Integração Diagnóstica: Dor Anal — Diagnóstico Diferencial

A dor anal é uma queixa que pode ter múltiplas etiologias. O raciocínio clínico estruturado — baseado em características da dor, tempo de evolução, relação com evacuação e achados ao exame físico — é essencial para distinguir as principais causas e evitar condutas equivocadas.



Características Diferenciadoras Essenciais

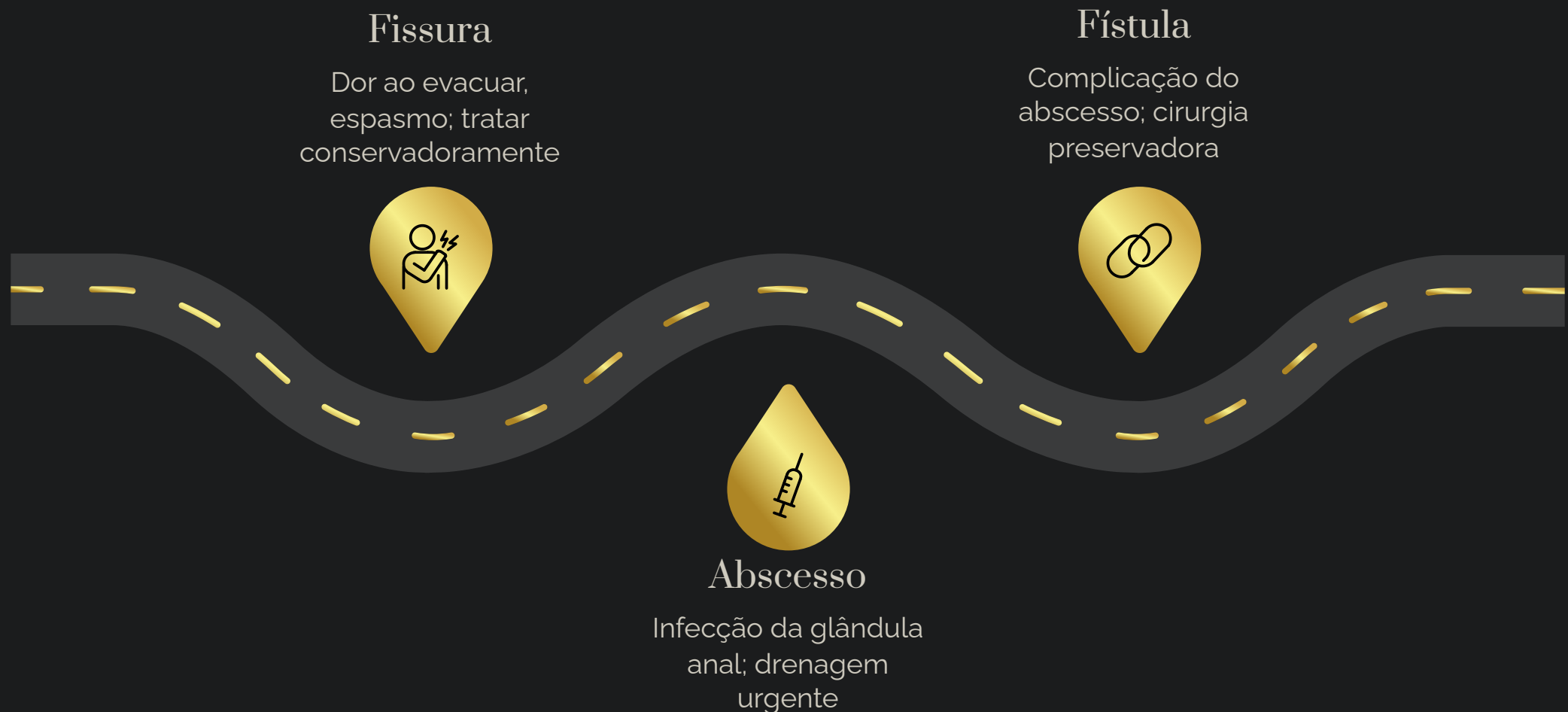
- **Dor somente ao evacuar + sangramento:** pensar em fissura
- **Dor contínua + febre + massa:** abscesso até prova em contrário
- **Dor súbita + massa azulada:** hemorroida trombosada externa
- **Dor noturna intermitente sem achados:** proctalgia fugaz

Armadilhas Diagnósticas

- Abscesso profundo sem sinais externos — não descartar por exame normal
- Fissura atípica lateral — pesquisar Crohn e DSTs
- Dor + massa dura + perda de peso — excluir neoplasia

Resumo Visual: As 3 Principais Afecções Anorretais

Ao final desta primeira unidade, é fundamental consolidar o raciocínio diagnóstico e terapêutico das três grandes afecções estudadas, reconhecendo suas interligações — especialmente a sequência abscesso → fístula, que representa a história natural mais comum na prática clínica.



A fissura anal, o abscesso anorretal e a fístula anorretal formam o núcleo das afecções benignas anorretais na coloproctologia clínica. Enquanto a fissura é uma entidade independente ligada ao traumatismo e hipertonia esfinteriana, o abscesso e a fístula fazem parte de um **mesmo espectro patológico** originado na glândula anal infectada — sendo a fístula a expressão crônica de um abscesso inadequadamente resolvido.

Fissura Anal

Principal causa de dor anal. Tratamento inicial conservador (~90%). Cirurgia reservada à forma crônica refratária.

Abscesso Anorretal

Urgência cirúrgica. Drenagem imediata é mandatória. Antibiótico não substitui cirurgia. 50% evolui para fístula.

Fístula Anorretal

Tratamento cirúrgico eletivo. Técnica depende da classificação. Preservação da continência é prioridade absoluta.

Pontos de Revisão e Próximos Passos

Esta primeira unidade abordou os fundamentos da coloproctologia — da anatomia à propedêutica, passando pelas três principais afecções benignas anorretais. Dominar esses conceitos é condição prévia para avançar nos temas da Apostila 2.

Checklist de Competências — Apostila 1

- Descrever a musculatura anorretal e sua função na continência
- Explicar a dualidade venosa e suas implicações clínicas
- Realizar e interpretar anamnese e exame físico anorretal
- Diagnosticar fissura anal e escolher a modalidade terapêutica adequada
- Reconhecer abscesso anorretal e indicar drenagem urgente
- Classificar fístula anorretal (Parks) e discutir opções cirúrgicas

Referências e Próximos Temas

Referências desta Unidade

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Coloproctologia
• Gordon & Nivatvongs — Principles and Practice of Surgery for the Colon, Rectum, and Anus • Estudos clínicos randomizados em fissura e fístula anorretal

Próxima Apostila

Hemorroidas (classificação, tratamento clínico e cirúrgico), Doença Pilonidal, Condilomas, Prurido Anal e Tumores do Canal Anal

  Revise os casos clínicos do repositório da especialização e pratique a interpretação de achados do toque retal e da anosscopia nos laboratórios de habilidades.